

02 - 02-Infections cutanées à HSV - Pr. Hocar

Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce cours de dermatologie dédié aux étudiants de 4ème année de MIT. Je suis professeure Hoka, professeure de dermatologie, chargée de vous faire la partie du cours consacré aux dermatoses infectieuses et aux dermatoses prurigineuses.

Nous allons commencer par les dermatoses virales et nous allons voir aujourd'hui les infections cutanées à herpes simplex virus. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont comme il suit, d'abord savoir expliquer le cycle du virus herpes simplex, savoir diagnostiquer cliniquement une primo-infection herpétique, puis savoir diagnostiquer une récurrence herpétique et diagnostiquer les formes graves de l'herpès et puis à la fin, il faut savoir traiter les infections herpétiques. Les virus cutanés sont dominés par les infections à herpès simplex virus, varicella zona virus et papilloma virus humain.

L'infection à herpès simplex virus est responsable d'atteintes cutaneo-muqueuses bénignes, rarement viscérales et graves. L'agent pathogène est l'herpès simplex virus qui est un virus à ADN dont on connaît deux types, l'herpès simplex virus type 1 et l'herpès simplex virus type 2. Ces deux virus ayant un grand degré d'homologie mais différenciés par des critères structureux et épidémiologiques. Classiquement, l'herpès simplex virus type 1 infecte plutôt la partie supérieure du corps et l'herpès simplex virus type 2 plutôt la région génitale, responsable d'une infection sexuellement transmissible et l'herpès du nouveau-né contaminé au passage de la filière génitale.

Il faut noter que les infections à herpès simplex virus atteignent l'homme qui est le seul réservoir, l'homme avec grand H et c'est des virus intracellulaires obligatoires. De façon schématisée, les sites cellulaires de l'infection latente de l'herpès simplex virus type 1 et type 2 sont le corps neuronal des ganglions sensitifs, les ganglions trigéminaux pour l'herpès simplex virus type 1 et les ganglions sacrés pour l'herpès simplex virus type 2. Et pour le varicelle zona virus, ce sont les neurones du ganglion sensitif rachidien et des paires crâniennes. L'herpès simplex virus type 1 atteint la partie supérieure du corps et la transmission se fait par contact direct, alors que l'herpès simplex virus type 2 atteint la partie inférieure du corps et la transmission se fait par contact génital.

Cette distinction n'est pas absolue car on peut isoler de l'herpès simplex virus type 1 de lésions génitales, 20 % de récurrence et près de 50 % dans la primo-infection. La prévalence des infections à herpès simplex virus type 2 est en constante augmentation depuis une quinzaine d'années, pouvant atteindre 15 à 30 % de la population générale, 50 % chez les hétérosexuels ayant une IST, 70 % chez les homosexuels. L'herpès génital est actuellement la première cause d'érosion et d'ulcération génital dans les pays développés.

La contamination survient surtout dans les deux premières décennies de vie sexuelle. L'herpès

néonatal est dû à un herpès simplex virus type 2 dans 75 % des cas et c'est dû à une contamination in utero, une contamination per partum et le risque de transmission est de 75 % si la maman a une primo-infection symptomatique, il est de 25 % si la maman présente une primo-infection asymptomatique et de 4 % si la maman présente une récurrence. Il faut noter qu'il y a un autre mode, c'est la contamination post-partum et peut être dû à l'herpès simplex virus type 1 ou type 2 à partir d'un herpès labial ou génital symptomatique chez la maman ou dans l'entourage.

L'infection herpétique passe par trois phases. D'abord la primo-infection qui est le premier contact infectant muqueux ou cutané symptomatique ou asymptomatique avec le virus, soit herpès simplex virus type 1 ou type 2. Et puis il y a la phase de latence et puis on a une phase de réactivation qui sont les périodes de réplication virale, séparées par des périodes de latence. Sur cette diapo, on peut voir le déroulement des infections à herpès simplex virus.

D'abord la primo-infection où le virus pénètre par une brèche cutané-muqueuse et se multiplie dans les cellules épithéliales, suivi par une phase de dormance ou de latence. Le virus est à l'état latent, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe d'une infection patente. Et puis ça arrive la phase de réactivation à tout moment sous l'influence de divers facteurs.

L'état de latence peut être rompu et le virus vient par voie axonale centrifuge recoloniser le territoire cutané-muqueux où avait eu la primo-infection. Donc il va provoquer des lésions plus limitées. Donc la récurrence est moins alarmante que la primo-infection mais volontiers récidivante.

La durée de l'excrétion virale est de 2 à 4 jours en cas de récurrence. La fréquence de récurrence est plus élevée en cas d'herpès génital à herpès simplex virus type 2 qu'à herpès simplex virus type 1. La fréquence de récurrence dépend de la qualité des défenses immunitaires cellulaires surtout. Les ultraviolets en émorbant les fonctions immunitaires cutanées favorisent les récurrences herpétiques lors des expositions solaires.

On peut résumer les facteurs qui stimulent les récurrences à herpès simplex virus dans ce tableau. On aura la fièvre, les maladies infectieuses, les traumatismes externes, notamment une chirurgie, dermabrasion, resurfassage, agents chimiques, irradiation ultraviolette et laser, le statut hormonal et menstruation, les corticoïdes, une immunodépression cellulaire soit héatrogène suite à la prise de certains médicaments immunosuppresseurs comme les corticoïdes et la chimiothérapie ou une immunodépression cellulaire infectieuse notamment au virus de l'HIV. Les chocs émotionnels peuvent induire des récurrences, notamment les angoisses, les dépressions, les stress et les rapports sexuels.

Dans ce diapos, on a schématiquement les différentes étapes de l'infection herpétique à herpès simplex virus type 1. Le virus pénètre par une brèche cutanée-muqueuse, se multiplie dans les cellules épithéliales, puis il disparaît et va par cheminement dans le nerf sensitif, se localiser

dans le ganglion nerveux correspondant où il reste quiescent en apparence. C'est la phase de latence virale car la transcription du génome viral n'aboutit pas à l'expression du protéine virale et dans la primo-infection, la durée d'expression virale est en moyenne de 8 jours mais peut atteindre 20 jours. Dans son repère ganglionnaire, le virus herpétique est très peu accessible au système immunitaire et au thérapeutique.

Nous allons voir maintenant les manifestations cutanées. D'abord la primo-infection à herpès simplex virus type 1. Il faut noter que la primo-infection à herpès simplex type 1 est souvent inapparente dans la plupart des cas. Les adultes sont porteurs d'anticorps sans avoir aucun souvenir de l'herpès initial.

Chez l'enfant, on assiste à une gingivostomatique herpétique aiguë, le plus souvent due à l'herpès simplex type 1. Cela atteint les enfants entre 4 mois et 6 ans. Pourquoi 4 mois ? C'est dès l'âge de disparition des anticorps protecteurs de la maman. On la voit rarement chez l'adulte.

Elle est asymptomatique dans 90% des cas et bien sûr patente avec des symptômes dans 10% et le plus souvent bénis. La durée d'incubation est de 2 à 20 jours. Après une incubation courte de 3 à 6 jours, on peut avoir un tableau clinique cutané précédé par des algies, des dysphagies, des persialorées.

Dans un contexte de malaise général avec une fièvre dépassant souvent 39 degrés. Sur les gencives tuméfiées, saignantes et sur la muqueuse buccale. L'apparition des érosions grisâtres et des érosions aftoïdes de vésicules embouquées sur le palais, les gencives, la langue, le pharynx et le plancher buccal.

Mais aussi sur la partie cutanée du montant et des lèvres. On peut avoir aussi des adénopathies somaxillaires et l'évolution est généralement favorable dans 10 à 15 jours. Sur cette photo, on peut voir une gingivose thomatique herpétique aiguë chez un nourrisson.

On peut distinguer sur les lèvres des lésions croûteuses à contours globalement polycycliques et des lésions blanchâtres sur la langue. On peut distinguer aussi sur la commissure labiale la présence d'érosions post-vésiculeuses et une vésicule qui se groupe embouquée. Sur cette photo, on peut voir des lésions aftoïdes du palais dans le cadre d'une gingivose thomatique herpétique.

Sur cette photo, on peut voir un aspect de panarie herpétique. Qu'est-ce que c'est le panarie herpétique? C'est des lésions vésiculeuses groupées embouquées globalement polycycliques avec une atteinte de l'appareil péri-inguéale. Chez un nourrisson qui présentait auparavant une gingivose thomatique herpétique et qui mettait les doigts dans la bouche et il a pu contaminer ses doigts de sa primo-infection herpétique buccale.

Sur cette photo, on voit un jeune adolescent qui présente une primo-infection herpétique avec atteinte palpébrale bilatérale et on voit bien des lésions vésiculeuses et des lésions pustuleuses

groupées en plaques polycycliques avec un aspect embouquée sur les parties internes. Sur cette photo, on voit une jeune adolescente qui présente une primo-infection herpétique avec des lésions groupées et typiquement embouquées sur la paupière inférieure, aspect qu'on peut aussi voir lors d'une primo-infection herpétique. Sur cette photo, on voit une femme âgée de 80 ans et qui présente une chylite érosive herpétique dans le cadre d'une récurrence herpétique.

Là, une autre patiente âgée de 72 ans qui présente des érosions éparpillées sur tout le visage et précédées par des lésions sur la lèvre qui sont croûteuses avec des croûtes hémorragiques. On voit les érosions aussi couvertes par des croûtes hémorragiques, chose qui pourrait s'expliquer par l'application de dermocorticoïdes sur un herpès, chose qui peut aggraver l'évolution des lésions. Toujours dans les manifestations cutanées de la primo-infection herpétique, nous allons voir maintenant la primo-infection génitale.

Elle est due le plus souvent à herpès simplex virus type 2. Cependant, l'herpès simplex virus type 1 est responsable de primo-infections génitales dans 10 à 20 %. Il faut noter qu'elle est symptomatique dans 60 à 80 % des cas. Elle est plus discrète chez l'homme que chez la femme. Chez la femme jeune, le tableau de primo-infection herpétique génitale se présente sous forme d'une vulvovaginite aiguë qui est extrêmement douloureuse et brutale, accompagnée de la fièvre et d'un malaise général.

Les fluorescences divisiculent sur la muqueuse vulvaire tuméfiée et éphémère et elle en constate surtout des érosions arrondies à contours polycycliques, parfois aftoïdes, s'étendant aussi vers l'anus. On peut avoir des lésions herpétiques coexistantes souvent sur les parois vaginales et le col, mais les douleurs rendent l'examen gynécologique quasi impossible. Elles débordent fréquemment sur le versant cutané, vers la racine des cuisses et le pubis et les fesses.

On peut avoir des adénopathies inguinales sensibles. On peut avoir de la rétention d'urines qui sont fréquentes. L'exacerbation des douleurs par la miction rend la chose très pénible.

La cicatrisation spontanée demande deux à trois semaines. Il faut noter qu'on peut avoir aussi des placards à bordures polycycliques sur les versants cutanés. Sur cette photo, on peut avoir l'aspect qu'on peut retrouver lors d'une vulvovaginite aiguë postherpétique.

Et là, on peut distinguer des érosions aftoïdes à fond beurré et des lésions polycycliques, des érosions polycycliques avec des locorées, aspects quasi compatibles avec une primo-infection génitale herpétique. La primo-infection génitale chez l'homme se présente sous forme d'un tableau clinique plus discret, similaire à une récurrence. Les lésions génitales généralement aux cicatrices en huit à quinze jours.

Il faut noter qu'on peut avoir une expression virale asymptomatique qui peut persister durant 20 jours à trois mois après l'épisode initial. Sur cette photo, on peut avoir un aspect d'une primo-infection herpétique chez l'homme qui se présente de façon moins intense et souvent confondue avec un herpès récurrent. On peut voir des vésicules, des érosions polycycliques post-

vésiculeuses, le tout groupé en bouquets sur un fond d'érythème, donc aspect qu'on peut retrouver lors d'une primo-infection herpétique chez l'homme.

On peut avoir d'autres aspects de la primo-infection herpétique. D'abord cutanée, il peut être discret, ce qui évoque une récurrence ou étendue et de topographie parfois radiculaire, qui fait discuter un zona. À l'âge adulte, on peut avoir une contamination professionnelle chez l'équipe soignante, médecin ou infirmière ou dentiste.

On peut avoir une contamination du doigt qui peut faire représenter l'herpès sous forme d'un panai. On peut avoir une atteinte oculaire qui est souvent due à l'herpès simplex virus type 1 et ça donne le tableau d'une keratoconjunctivite unilatérale aiguë avec quelques vésicules sur les paupières ou des maciers et une adénopathie pré-thragienne. On peut avoir aussi la keratite superficielle qui guérit rapidement s'il n'y a pas eu de corticothérapie locale à temps passif.

On peut avoir des atteintes ORL sous forme d'angines herpétiques, mais aussi on peut avoir une anorectite qui réalise un tableau d'anorectite aiguë avec TENES. Sur ce diapos on peut avoir une atteinte ophtalmologique, donc à gauche on a une keratite herpétique superficielle d'andriti qui abroite l'aspect à l'examen ophtalmo de l'ulcération en feuilles de fougère qui est très évocatrice d'herpès. Cette photo montre une keratite dissyforme.

On distingue deux anneaux de Weasley qui entraînent un ODM dissyforme de la cournée. Ils surviennent suite à des récurrences répétées de l'infection au niveau de la cournée qui est gagnée par les anticorps et les cellules immunes d'une réaction immunopathologique. Dans le cadre des manifestations cutanées à herpès simplex virus, maintenant nous allons voir les récurrences herpétiques.

Au moins 80% de la population adulte héberge l'herpès simplex virus à l'état latent et seuls 20% présentent des récurrences cliniques favorisées par de nombreux facteurs déclenchants, comme les a vus tout à l'heure. D'abord une infection générale fibrille, une exposition aux ultraviolets, les menstruations, le stress, les traumatismes, soit par du laser, par des dermabrasions, soit par juste un soin dentaire, la chirurgie régionale, les injections de morphine intratécale et les rapports sexuels. Sur le plan clinique, les prodromes précédant la récurrence peuvent se résumer sous forme de sensations de cuisson, de picotement ou de prurite sur la zone où il va y apparaître les lésions et puis une plaque érythémateuse précédant de quelques heures l'apparition des vésicules en tête d'épingle groupées en bouquets qui confluent parfois en formant une bulle.

Puis ils vont se remplir, laissant place à une érosion suivie d'une croûte qui tombe en quelques jours. La guérison est spontanée, se fait sur 8 à 10 jours en laissant une lésion érythémateuse au pigmenté. Les signes d'accompagnement sont absents au minimum, se forment d'un petit fibricule ou de petites adénopathies.

L'herpès récurrent peut siéger n'importe où, mais pour un malade donné, la récurrence a lieu au

même endroit déterminé par le siège de la primo-infection herpétique. La fréquence des récurrences diminue souvent avec l'âge. On peut distinguer sur la région faciale l'herpès labial, ce qu'on appelle aussi communément le bouton de fièvre, à cheval sur la demi-miquieuse et la peau, parfois plus étendue.

On peut avoir de l'herpès nasal au narinaire, pouvant simuler une folliculite, et aussi la stomatite herpétique avec des érosions douloureuses de la gencive. On peut avoir sur la région oculaire la chératite herpétique, dont la gravité est liée aux ulcérations de la cornée, pouvant aboutir à une perte de la vision, parfois associée à une uvéïte. Il faut noter que l'herpès oculaire nécessite un avis spécialisé urgent.

On peut avoir aussi de l'herpès génital récurrent, particulièrement récidivant et de diagnostic parfois difficile. Donc, c'est des lésions afoïdes, fissuraires, surinfectées, odémateuses, papilles érosives, l'existence de prodromes et le caractère récurrent au même endroit sont des arguments pour le diagnostic. Les récurrences herpétiques génitales sont plus fréquentes avec l'herpès simplex verustype 2, qui sont de 90% plus que l'herpès simplex verustype 1, qui est de 60% des cas.

La topographie des lésions se voit sur la région génitale externe et sur la peau périneo-fessière. Il faut noter que les excréments viraux asymptomatiques entre les récurrences sont fréquentes, et c'est la cause majeure de l'herpès neonatal. Il faut noter que les arguments diagnostiques, c'est surtout l'existence des prodromes et le caractère récurrent au même endroit des érosions au niveau de la région génitale, qui doit être parfois confirmé par la mise en évidence du virus.

Cette confirmation est recommandée au moins une fois chez la femme susceptible de procréer afin d'apprécier le risque d'herpès neonatal. Il faut noter que l'herpès génital, c'est une maladie chronique et contagieuse, donc les mesures d'éviction sont recommandées. Nous allons voir maintenant les formes graves et compliquées des infections à herpès simplex virus.

D'abord, la méningo-encéphalite herpétique, c'est la cause la plus fréquente des encéphalites virales. Elle est exceptionnelle au cours d'une récurrence chez l'adulte. Elle est due à herpès simplex virus type 1 suite à une pré-infection ou à une récurrence.

Et sur le plan clinique, elle se manifeste par de la fièvre, des céphalées et, d'ici, une neurologie de localisation. Deuxième tableau grave, c'est l'ozophagite, qui est souvent dû à herpès simplex virus type 1 et qui souvent se voit chez l'immunodéprimé, surtout le patient HIV. Et les hépatites et les pneumopathies, qui sont des manifestations rares, mais elles sont graves, on les voit souvent chez la femme enceinte et l'immunodéprimé.

Toujours dans les manifestations cutanées, des formes graves et compliquées, on va voir une forme grave selon un terrain de débilite immunitaire, c'est l'herpès de l'immunodéprimé. Il faut noter que les récurrences sont fréquentes, elles sont atypiques et prolongées. Elles donnent des ulcérations torpides en fond nicotique.

Dans les bords, présente parfois des vésicules opustules sur lesquelles le prélèvement doit porter pour permettre le diagnostic. Il faut noter qu'il y a possibilité de dissémination viscérale. Toujours dans les formes graves selon le terrain, chez le nouveau-né, l'herpès est rare, mais grave.

En cas de transmission du virus in utero, on observe un avortement, retard de croissance intra-utérin, mais aussi des atteintes oculaires, neurologiques et cardiaques. L'herpès néonatal se présente sous trois formes. D'abord, une forme cutaneo-muqueuse qui ne s'accompagne pas de mortalité.

Une atteinte neurologique avec une mortalité qui atteint les 15% des cas avec des séquelles fréquentes. C'est la forme avec méninge en céphalite. Et une atteinte systémique avec un tableau disséminé fait d'une atteinte polyviscérale avec une atteinte cérébro-mélangée, hépatosplénomégalie, atteinte pulmonaire.

Dans ce cas, la mortalité est élevée à 60%. Une autre forme grave, c'est le syndrome de Kaposi-Julisberg. C'est quoi ce syndrome? C'est une surinfection herpétique d'une dermatose sous-jacente, comme la dermatite atopique, ou une dermatose bulleuse, comme le pemphigus, ou visculeuse, comme les eczèmes.

C'est peut-être dû à une primo-infection ou à une récurrence. Il peut se développer par greffe du virus herpétique sur un eczéma profus. Des vésicules hémorragiques et des pustules classiquement ambulatoires s'étendent rapidement du visage à l'ensemble du corps.

Dans un contexte d'altération de l'état général, une fièvre à 40 degrés Celsius. L'évolution est favorable, ce traitement antiviral parentéral. Il faut noter que le syndrome de Kaposi-Julisberg peut être dû parfois à des récurrences, mais aussi à une primo-infection.

Il faut noter qu'on peut avoir une atteinte viscérale possible associée à ce tableau clinique. Ces photos illustrent un tableau clinique du syndrome de Kaposi-Julisberg chez un nourrisson atteint d'une dermatite atopique. On note les érosions polycycliques et hémorragiques étendues sur la région céphalique et aussi sur les membres inférieurs dans un contexte de fièvre et d'altération de l'état général.

Donc, il faut hospitaliser ces enfants et procurer un traitement par voie intraveineuse à base d'antiviral. La récurrence herpétique peut être suivie d'un hérithème polymorphe avec des lésions cutanées, maculopapuleuses, insulaires ou encoucardes, parfois bulleuses, souvent associées à une atteinte muqueuse. Celui-ci est susceptible de récidiver à chaque poussée.

L'herpès est la cause la plus fréquente de l'hérithème polymorphe récidivant. Donc, vous pouvez voir le cours des dermatoses bulleuses. Sur cette photo, on voit un enfant de 8 ans qui présente un hérithème polymorphe avec une atteinte oculaire et une atteinte buccale, génitale.

On voit les lésions encoucardes, qui sont des lésions insibles avec trois éléments concentriques caractéristiques de l'hérithème polymorphe. Le diagnostic est essentiellement clinique par la mise en évidence de lésions typiques faites de vésicules groupées en bouquets ou des érosions polycycliques sur des endroits évocateurs de l'herpès. On peut avoir recours à des méthodes plus appropriées quand on est devant un herpès néonatal, une femme enceinte avec suspicion d'herpès, une atteinte viscérale grave et des aspects typiques.

On peut proposer le cétiagnostic de Zhang. C'est un examen qui met en évidence l'effet cétopathogène du groupe herpès virus. Ça veut dire un oedème cellulaire, des cellules multinucléées, des inclusions intranucléaires.

C'est une méthode simple, rapide et peu coûteuse, mais peu sensible et elle est peu utilisée en pratique. On peut aussi proposer la recherche d'antigènes viraux par méthode d'immunofluorescence directe, mais aussi par méthode d'ILISA. Ce sont des méthodes d'utilisation courante dans de nombreux laboratoires.

Ce sont des méthodes rapides avec un délai de réalisation d'une à cinq heures, mais de sensibilité médiocre pour des lésions à un stade avancé, notamment le stade croûteux. La culture virale, c'est la méthode de référence, mais qui peut aussi nous rendre service en mettant en évidence les particules virales. Ça se fait par inoculation à des cultures cellulaires sur lesquelles l'effet cétopathogène est observé en moyenne entre deux à trois jours.

L'APCR est un moyen aussi valide pour le diagnostic, mais ça ne se pratique pas de façon courante en pratique. Un autre moyen, c'est le diagnostic indirect ou diagnostic sérologique. Le diagnostic de primo-infection repose sur la mise en évidence d'une séroconversion entre un sérom précoce et un sérom tardif au moins dix jours après le premier.

Les techniques actuelles n'ont pas d'intérêt. La sérologie herpès simplex virus type 2 peut apporter des renseignements chez les couples séronégatifs et chez la femme enceinte. On arrive au chapitre traitement de l'infection herpésicutanée.

D'abord, les moyens dont on dispose pour traiter ces infections. On a besoin d'antiseptiques comme la chlorhexidine, mais aussi de la bétazine. On peut avoir besoin d'antiviraux locaux sous forme de crèmes, mais aussi des antiviraux par voie générale.

On a l'acyclovir, osovirax ou cyclovirale. C'est un médicament phosphorylé en acyclovir très phosphate qui est la forme active du médicament qui inhibe l'ADN polymérase virale. L'acyclovir n'est métabolisé que dans les cellules infectées par l'herpès simplex virus et offre ainsi un très bon rapport bénéfice-risque.

Des souches résistantes à l'acyclovir sont apparues chez les patients immunodéprimés. Il y a aussi la valacyclovir qui est un prodrogue de l'acyclovir qui a une meilleure biodisponibilité avec une augmentation très importante de l'absorption digestive. Et on a aussi le foscarnine.

Les indications, d'abord la primo-infection virale. On peut proposer l'acyclovir, ce forme de comprimé dosé à 200 mg 5 fois par jour. Ça fait 1 g par jour durant 10 jours.

Aussi, la forme intraveineuse à la dose de 5 mg/kg toutes les 8 heures pour 5 à 10 jours. Généralement, chez les enfants de moins de 3 mois, on peut proposer 250 mg par mètre carré par 8 heures. On peut proposer le valacyclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours ou le foscarnet 250 mg 2 fois par jour pendant 10 jours.

Pour les récurrences herpétiques, il n'y a pas de recommandation spéciale. On peut proposer un antiseptique. On peut proposer des antiviraux locaux, ce forme de Zovirax Crème, Cycloviral Crème pendant 5 jours.

On peut proposer des traitements par voie générale, antiviraux par voie générale, si on a des formes sévères. S'il s'agit d'un herpès néonatal, le traitement doit être précoce sans attendre la confirmation, vu la gravité du tableau clinique. Et on peut démarrer l'acyclovir à la dose de 500 mg par mètre carré par 8 heures pendant 14 jours si on a des formes localisées et pendant 21 jours si on a des signes neurologiques ou une atteinte dissimulée.

Une prévention antiherpétique est recommandée chez les patients ayant plus de 6 récurrences génitales par an, mais aussi chez les patients immunocompétents présentant plus de 6 récurrences orofaciales par an. Donc à la dose de 500 mg, la molécule élève l'acyclovir une fois par jour. On peut aussi proposer l'acyclovir 400 mg deux fois par jour pendant 6 à 12 mois.

On peut proposer aussi un traitement antiherpétique préventif en cas d'une primo-infection herpétique pendant le mois avant l'accouchement et à ce moment on administre à la maman l'acyclovir 1 g par jour jusqu'à l'accouchement. On peut proposer une césarienne si les lésions sont apparues au cours de l'accouchement et bien sûr éviter le contact avec toute personne ayant un herpès.